

抑郁症治疗中药物相互作用引起的反应

王建军 张文广

新疆兵团六师奇台医院 奇台县 831800
新疆乌鲁木齐儿童医院 乌鲁木齐市 830003

1 抗抑郁症药物

抗抑郁药是一类用于减轻或治疗各种情感障碍的精神类药物,主要的抗抑郁药类型包括单胺氧化酶抑制剂(MAOI),三环类药物,选择性5-羟色胺再吸收抑制剂(SSRI)。

1.1 单胺氧化酶 异丙肼是上世纪50年代问世的第一个抗抑郁症药物,1957年试用于抑郁症病人并获得成功,属于这一类药物的还有异卡波肼、苯乙肼、反苯环丙胺等。

1.2 三环类抗抑郁药物 此类药物是国内应用范围最广的药物,它是治疗抑郁症的首选药,垄断了抗抑郁药市场30年之久。三环类抗抑郁药共有产品10余种,我国除丙咪嗪外还有阿米替林、多虑平和氯丙咪嗪。三环类抗抑郁药临床应用时间最长,药理作用研究的也最多最充分。

1.3 新型药物 选择性5-HT再摄取抑制剂(SSRI)是新型抗抑郁药物。本类药物从20世纪70年代开始研制,已开发有数十种,临床常用的有氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、西酞普兰等。本类药物镇静作用小,也不损伤精神运动功能,对心血管和自主神经系统功能影响很小。本类药物还具有抗抑郁和抗焦虑双重作用,多用于脑内5-HT减少所致的抑郁症。

2 药物的不良反应及相互作用

2.1 单胺氧化酶的不良反应及相互作用 (1)不良反应 这类药物曾经一度广为应用,但不久陆续出现了与某些食物和药物的相互作用,引起了高血压危象、急性黄色肝萎缩等严惩不良反应而被淘汰。

(2)单胺氧化酶与其它药物相互作用 单胺氧化酶是去甲肾上腺素,它主要参与多巴胺的代谢。与香豆素类以及茛满二酮类衍生物可导致其抗凝作用增强甚至出血与赛庚啶等受体阻断药合用可使其作用和毒性增加与吩噻嗪类抗精神病药合用可导致高血压并加重锥体外系反应与巴比妥类药物合用可延长巴比妥类的中枢神经系统抑制作用与苯妥英钠合用导致后者毒性增强与乙醚以及水合氯醛合用使后者增强。

2.2 三环类药物的不良反应及相互作用 (1)不良反应 此药物会使人体重变沉,容易感到困倦,眼睛看不清楚东西,困倦、口干、心跳加快、排尿困难和体

位性低血压。而且还可能有毒副作用,对中枢神经系统和心血管都有不良的影响。可能会使人昏迷、意识模糊,此药物的毒副作用一般与血药浓度有关,如果他的浓度高于正常水平,癫痫病就容易出现患者中。(2)三环类药物与其它药物相互作用 很多药物对三环类药物都有一定影响,比如口服避孕药、利福平、卡马西平等。这些药物的相互作用使得其浓度提高,影响代谢,从而使此药的药效就没有了。

2.3 新型药物的不良反应及相互作用 新型药物一般包括5-HT、NE再摄取抑制剂(SNRI)和选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)。(1)不良反应 强大的奎尼丁效应可引起低血压、口干等,老年中又易引起排尿困难、跌倒等风险。随着这些新型药物的使用,也发现有些不良反应。比如说用药初期引起的恶心、呕吐、食欲不振等胃肠道反应,而且胃肠道的不适极易引起体重的下降。比如说性功能障碍,而且在男性中发病率较高。最常见的性功能障碍时性高潮的缺失。(2)新型药物相互作用

文拉法新的单胺氧化酶抑制剂一同使用危害效果极大,如不慎用药,危险者可能致命。5-羟色胺再摄取抑制剂的具体药品有氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等。氟西汀和三环类抗抑郁药物出现相互作用,会出现癫痫等症状。氟西汀与单胺氧化酶抑制剂的相互作用会出现焦虑不安,严重时会导致死亡。氟西汀与非精神病药物联用出现的相互作用,因为氟西汀对酶的代谢有影响。

3 抑郁症的治疗

3.1 抑郁症的西医治疗 (1)药物治疗抑郁症发作往往有复发倾向。因此,治疗的目的有二:控制急性发作和预防复发。第一,药物选择。抑郁病人应严防自伤和自杀,如自杀观念强烈应果断实施电痉挛治疗,得病情稳定后再用药物维持和巩固。目前仍把TCAS作为治疗抑郁的一线药,第二代非典型抗抑郁药为二线药,其次可考虑MAOIS。第二,疗程和剂量。治疗的成功除正确诊断,合理选择药物外,疗程和剂量至关重要。常见的错误在于对抑郁症的复发和自杀危险性认识不够,因此常常剂量低、疗程短。抑郁症可分三期治疗:(1)以控制症状为目

标的急性治疗期,用足够剂量至症状消失。(2)以巩固疗效,避免病情反复为目标的继续治疗期,症状消失后至完全恢复约需4—9个月,如未完全恢复,病情易反复。(3)防止复发为目标的预防性治疗期,后两期不易截然分开,常统称为维持治疗。第三,认知治疗。治疗目的在于让病人认识到自己错误的推理模式,从而自觉主动纠正。

除此之外,可以另辟蹊径。此方法有电痉挛治疗,替代性疗法、实验疗法、女性荷尔蒙补充疗法HRT、反射疗法、运动疗法等。

3.2 抑郁症的中医治疗 第一,脾肾阳虚。治宜温补脾肾,以养肝解郁为主。表现为在情感抑郁等的症状的基础上,兼见嗜卧少动,惊恐多疑,自责自罪,甚或有轻生厌世的意念和行为,消瘦乏力,腹胀便溏,舌淡胖,边有齿痕,苔白或滑,脉象沉细,或兼弦滑。第二,心脾两虚。治宜健脾养心,以理气解郁为主。表现为在情感抑郁等症基础上,兼见心悸易惊,失眠健忘,自觉思维迟钝,工作或学习效率下降,有自责自罪及疑病倾向,消极沉闷,倦怠乏力,腹胀便溏,或口干便结。第三,肝虚气滞。治宜温胆养肝,以理气解郁为主。表现为情感抑郁,悲观失望,忧心忡忡,兴致索然,面容愁苦,沉默寡言,其情感变化有昼夜轻的特点(如白昼抑郁,入夜稍缓或兴奋,甚或判若两人),可伴有两胁不适或胀满,失眠多梦,容易疲倦,纳呆少食,舌苔薄白,脉象弦细,或虚弦。

4 抑郁症药物的研究进展

随着多种应激因素的加剧,抑郁症以成为现代社会的常见病,严重危害着人类的身心健康。近年来,随着对抑郁症病理生理改变认识的逐步加深,抗抑郁药的研究也取得了一些进展。

(1)瑞波西汀,选择性NE再摄取抑制剂,选择性高、不良反应少、疗效较好。临床表明该药抗抑郁效果与SSRI类似,适用于内源性、更年期抑郁症。

(2)丁螺环酮,国内外一些精神科专家学者研究证实了它对抑郁症治疗有效果,而且它对抗抑郁剂有增效作用,合用抗抑郁剂治疗抑郁症具有良好的协同疗效,不增加不良反应。

结语:抑郁症作为当今社会的一大疾病已经引起了人们的广泛关注,抑郁症有三大主要症状,就是情绪低落,思维迟缓和运动抑制。医学专家在伦敦抑郁症国际讨论会上指出,到2020年抑郁症很可能会成为除心脏病之外给社会经济造成负担最大的一种疾病,科学家认为抑郁症的危害程度巨大,发展中国家的抑郁症治疗条件还很匮乏,因此研究抑郁症下药物相互作用的反应并找到解决不良反应的措施就对人类社会做出了很大的贡献。

参考文献

[1] 徐磊,封宇飞. 5-羟色胺—多巴胺受体部分激动剂依匹哌唑

的药理作用与临床评价[J]. 中国新药杂志,2016,(05):481—483+511.

- [2] 曹银,梁俊,戴彪,赵莹莲,夏清荣. 市级医院门诊药房药物咨询情况分析[J]. 安徽医药,2016,(11):2177—2179.
- [3] 汪卫华,刘丽,李光耀,隋云川,赵汉清,何益明. 抑郁症患者血清瘦素和脑源性神经营养因子与疗效的相关性[J]. 临床精神医学杂志,2015,(05):332—334.
- [4] 杨玲,王帆,康毅敏,刘彦隆,张媛. 代谢相关因子在抑郁症中的研究进展[J]. 中国药物依赖性杂志,2015,(05):337—340+400.
- [5] 钟家菊,李志伟,谢鹏. 细胞因子与抑郁症[J]. 中风与神经疾病杂志,2015,(06):571—572.
- [6] 张青霞,闫素英,裴斐,李丹丹. 从1例反复支架内血栓伴抑郁患者探讨舍曲林与抗血小板药物的相互作用[J]. 中国药物应用与监测,2015,(02):85—87.
- [7] 张璐,王飞虎,陈赛贞,潘建春. 天然抗抑郁药物与细胞色素P450的相关研究进展[J]. 中国中药杂志,2015,(05):828—832.
- [8] 徐说,林文娟. 抗炎性细胞因子与抑郁症[J]. 生物化学与生物物理进展,2014,(11):1099—1108.
- [9] 刘勤. 抗抑郁症药物不良反应及药物相互作用[J]. 大家健康(学术版),2014,(18):113.
- [10] 梁春生. 艾司西酞普兰与帕罗西汀治疗老年性抑郁症的对照分析[J]. 中国医药指南,2014,(23):145—146.
- [11] 唐劲年,胡宗继,巴特尔,李哲,刘立雄. 中老年大面积脑梗死的非手术治疗效果[J]. 中国医药科学,2014,(09):205—207.
- [12] 杨青. 编者推荐[J]. 中国新药杂志,2014,(03):240.
- [13] 张莹. 艾司西酞普兰与帕罗西汀治疗老年抑郁症72例对照研究[J]. 现代诊断与治疗,2013,(07):1633—1634.
- [14] 叶冬青,张志珺,李扬. TREK1钾通道与抑郁症[J]. 药理学报,2012,(11):1403—1408.
- [15] 孟江平. 抗抑郁新药琥珀酸去甲文拉法辛的研究进展[J]. 中国药房,2012,(10):927—929.
- [16] 汪春运. 6种新型抗抑郁药的相互作用[J]. 四川精神卫生,2012,(01):52—56.
- [17] 徐涛,吴素焕,武变瑛,李玉欣,郭艳梅,韩彦超. 舒肝解郁胶囊与舍曲林治疗抑郁症的临床对照研究[J]. 中国医药导刊,2011,(09):1654—1655.
- [18] 杜佳. 抗抑郁药地昔帕明与抗癌药物的相互作用[J]. 医学信息(中旬刊),2011,(08):3817—3818.
- [19] 林建忠,周秀玉. 艾司西酞普兰与帕罗西汀治疗老年期抑郁症60例的对照研究[J]. 中国民康医学,2011,(03):307—308.
- [20] 喻东山,臧家平. 舍曲林在精神疾病中的应用[J]. 医学研究生学报,2009,(04):434—437.
- [21] 陈福新. 卡马西平的药物相互作用[J]. 中国执业药师,2008,(02):30—32.
- [22] 张慧敏,许晶,李明. 抑郁症治疗依从性的相关因素分析[J]. 中国临床康复,2006,(46):16—18.
- [23] 李喆,孙学礼. 下丘脑—垂体—肾上腺轴与抑郁症的相关性[J]. 中国临床康复,2006,(42):130—133.
- [24] 舒良. 抗抑郁剂治疗容易被忽视的问题——CYP450酶介导的药物相互作用及其临床意义(综述)[J]. 中国心理卫生杂志,2006,(10):699—701.
- [25] 汤艳清,谢光荣. 抑郁症脑功能影像学研究进展[J]. 中国神经精神疾病杂志,2005,(06):482—485.

- [26] 何小林,郑洪波,余金龙,郭建雄. 精神科医生选择抗抑郁药物时最先考虑的影响因素[J]. 中国临床康复, 2005, (24): 6—7.
- [27] 曹晶. 抑郁症与冠心病[J]. 中国心血管杂志, 2004, (02): 153—156.
- [28] 文彬,郑家富. 抗抑郁症药物不良反应及药物相互作用[J]. 中国临床康复, 2003, (12): 1804—1805.
- [29] 王金城. 选择性 5-HT 再摄取抑制剂的药理和临床[J]. 国外医学. 麻醉学与复苏分册, 2001, (01): 22—23.
- [30] 胡文能. 术前必须停用单胺氧化酶抑制药吗? [J]. 国外医学. 麻醉学与复苏分册, 1986, (05): 308—309.

新疆奎屯垦区 2011—2015 年居民食用碘盐现状调查

方娟

新疆兵团七师疾病预防控制中心 奎屯市 833200

摘 要 目的:了解奎屯垦区 2011—2015 年合格碘盐的食用情况。方法:按照《全国碘缺乏病监测方案》要求,对所辖 10 个团场随机各抽取居民食用盐,碘盐检测采用 GB/T13025. 7—1999 和 GB/T13025. 7—2012 中直接滴定法。合格碘盐的判定标准:20—50mg/kg,非碘盐的判定标准为: $<5\text{mg/kg}$ 。结果:2011—2015 年共抽取居民户碘盐 2370 份,居民食用合格碘盐率分别是 97.33%,97.83%,99.38%,99.78%,100.00%。食用不合格碘盐率分别为 2.67%,1.83%,0.63%,0.22%,0.00%。食用不合格碘盐率呈逐年下降趋势。结论:奎屯垦区居民食用碘盐情况良好,但需加强食用碘盐监督监测工作,以及加强居民对碘盐缺乏知识的防治和宣传工作。

关键词 碘;碘盐;碘缺乏病

我国是世界上碘缺乏病流行最严重的国家之一,国家制定了 2010 年实现消除碘缺乏病目标。新疆位于中国西北,地处亚欧大陆腹地,远离海洋,四周高山环绕,是典型的缺碘地区。碘缺乏病是严重危害人体健康的地方病,碘是人体生长发育新陈代谢必需的元素,食用加碘盐是消除碘缺乏病的关键措施,根据卫生部的要求,按照国家标准分析方法,2011—2015 年我们对新疆奎屯垦区 10 个团场 2370 户居民的食用碘盐进行了测定比较,现将分析结果报告如下:

1 材料与方法

1.1 样品来源:依据《全国碘缺乏病防治检测方法》中规定的方法制定了《兵团第七师碘盐监测方案》,碘盐质量检测按随机性的原则选择,2011—2015 年按照国家要求抽检了奎屯垦区的 10 个团场,每个团场随机检测 4 个连队盐样,2011—2015 年共抽检盐样 2370 份。

表 1 居民户碘盐含量情况表

年份	检测份数	合格碘盐	不合格碘盐	无碘盐	合格率%
2011 年	600	584	16	0	97.33
2012 年	600	587	11	2	97.83
2013 年	320	318	2	0	99.38
2014 年	450	449	1	0	99.78
2015 年	400	400	0	0	100.00
合计	2370	2338	30	2	98.65

2 结果与分析

2011 年—2015 年奎屯垦区居民盐样检测共 2370 份样品,检出合格碘盐 2338 份,合格率为 98.6%;不合格碘盐 32 份,占 1.35%(含 24 份大于 50mg/kg 的碘盐,非碘盐 2 份)。通过监测数据分

析发现,奎屯垦区居民碘盐食用率均达到 90%以上,不合格碘盐率呈逐年下降趋势,并已达到国家消除碘缺乏病的标准。但部分居民的食用盐碘含量偏低,含量在 20—30mg/kg 的碘盐极易因储存和使用不当造成含碘量降低而导致食用不合格碘盐。应实

1.2 检测方法:盐碘测定按 GB/T 13025. 7—1999 和 GB/T13025. 7—2012《直接滴定法》测定。特殊盐种采用仲裁法定量检测。

1.3 判定标准:盐碘合格判定标准依据 GB 26878—2011《食用碘盐含量》合格碘盐 20—50mg/kg,不合格碘盐 5—20mg/kg(或 $>50\text{mg/kg}$),非碘盐 $<5\text{mg/kg}$ 。

1.4 质量控制:样品的采集、保存、运输、检测均由经兵团疾控中心培训的专业人员负责,使用统一方法和标准。盐碘实验室通过国家参照实验室盐碘外质控考核合格。

1.5 统计分析:用 Excel 建立统一数据库进行统计分析。由于碘盐数据为偏态分布,用中位数进行描述。

2 结果

2.1 碘盐检测结果 2011—2015 年抽检盐样检测结果如下表所见。

析发现,奎屯垦区居民碘盐食用率均达到 90%以上,不合格碘盐率呈逐年下降趋势,并已达到国家消除碘缺乏病的标准。但部分居民的食用盐碘含量偏低,含量在 20—30mg/kg 的碘盐极易因储存和使用不当造成含碘量降低而导致食用不合格碘盐。应实